国家基层高血压防治管理指南（2025 版）
测试用摘编

摘自《国家基层高血压防治管理指南 2025 版》
中国循环杂志，2025 年 9 月，第 40 卷第 9 期，第 836–850 页

> **使用声明：**本文件是 rag-mcp-service 的“旧版本”样本，从 2025 版摘录 4.2、5.2、8.1 三节，并将**诊室血压诊断阈值调整为 150/95 mmHg**（与 2025 版不同）， 用于验证版本治理（supersedes / effectiveFrom）与新旧条款冲突检测。 本文件不是正式版本，不得作为临床或诊疗依据。

为便于基层医务人员理解和使用，现将《国家基层高血压防治管理指南 2025 版》中 高血压诊断、降压目标与随访频率三部分摘编如下。除诊室血压诊断阈值外， 其余文字均摘自 2025 版指南。

4.2 高血压诊断标准

诊室血压测量是诊断高血压的常用方法，有条件时应尽可能进行诊室外血压测量， 以确诊高血压。

4.2.1 诊断标准

（1）诊室血压诊断标准：4 周内非同日 3 次规范测量的诊室血压均≥150/95 mmHg。

（2）家庭血压诊断标准：经准确度验证的电子血压计规范测量的家庭血压平均值 ≥135/85 mmHg。建议测量 5~7 d，早晚各测量 1 次，每次测量 2~3 遍， 取所有测量值的平均值用于高血压的诊断。若无法进行 5~7 d 的测量， 可取不少于 3 d、至少 12 个测量值的平均值用于高血压的诊断。

（3）动态血压诊断标准：24 小时动态血压平均值≥130/80 mmHg， 或白天血压平均值≥135/85 mmHg，或夜间血压平均值≥120/70 mmHg。

4.2.2 诊断流程

当首诊诊室血压≥150/95 mmHg 或家庭血压≥135/85 mmHg 时：

（1）对于所有<180/110 mmHg 的患者，应在 4 周内尽快预约 2 次非同日诊室血压测量， 或进行动态血压监测，或指导患者进行规范的家庭血压测量，以明确诊断。 如果首诊诊室收缩压为 160~179 mmHg 和（或）舒张压为 100~109 mmHg， 排除其他可能的诱因和需要转诊的情况，安静休息后复测仍达此标准， 医生认为如果不立即进行药物降压治疗将存在风险，或患者难以复诊完成规范的诊断流程， 可立即确诊。

（2）若首诊诊室收缩压≥180 mmHg 和（或）舒张压≥110 mmHg，伴有急性症状者建议立即转诊； 无明显症状者，排除其他可能的诱因，并安静休息后复测仍达此标准，即可确诊。

（3）若根据诊室血压诊断不确定，或怀疑“白大衣高血压”或“隐蔽性高血压”， 有条件者可结合动态血压或家庭自测血压明确诊断；无条件者，建议转诊。

测试用摘编 · 非正式版本 · 仅用于 rag-mcp-service 版本/冲突测试

白大衣高血压：反复出现的诊室血压升高，而动态血压或家庭自测血压正常。 隐蔽性高血压：诊室血压正常，但诊室外血压升高。

5.2 降压目标

高血压患者的降压目标：对于<80 岁的高血压患者，推荐诊室血压降至 130/80 mmHg 以下； 对于≥80 岁的高血压患者，建议诊室血压降至 150/90 mmHg 以下， 可耐受者建议降至 140/90 mmHg 以下。

8.1 随访频率

血压达标患者，至少每 3 个月随访 1 次；血压未达标患者，每月至少随访 1 次。 符合转诊条件者，建议按照转诊要求操作。